ESE Hospital Sintético San Jerónimo

Código de habilitación 230010999903 · HISTORIA CLÍNICA DE HOSPITALIZACIÓN

DATOS DEL PACIENTE

USUARIO: VALENTINA SANDRA GOMEZ MARTINEZ DOCUMENTO: CC 1029141699 EDAD: 71 años SEXO: FEMENINO

FECHA DE NACIMIENTO: 23-07-1954 PROCEDENCIA: Cereté DIRECCIÓN: Avenida 51 # 15-75

TELÉFONO: 306 489 9830 ASEGURADORA: Mutual Ser HISTORIA: HC-2026-4109 EPISODIO: ADM-270090

FECHA DE INGRESO: 12-05-2026 15:46 SERVICIO: HOSPITALIZACIÓN

MOTIVO DE CONSULTA

«No puedo respirar bien y tengo las piernas hinchadas».

ENFERMEDAD ACTUAL

Disnea progresiva de una semana hasta hacerse de reposo, ortopnea de tres almohadas y edema de miembros inferiores. Ganancia de 4 kg en 10 días.

Según refiere su familiar Mauricio Mateo Cabrales Gutierrez, el cuadro empeoró en las últimas horas.

ANTECEDENTES

Personales: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, hipertensión arterial. Familiares: sin relevancia. Alérgicos: niega.

EXAMEN FÍSICO

TA 160/100 mmHg, FC 104 lpm, FR 26 rpm, SatO2 89 % al aire ambiente, T 36,4 °C. Ingurgitación yugular, crépitos bibasales, edema grado III en miembros inferiores.

ANÁLISIS

Falla cardíaca descompensada con congestión pulmonar y sistémica. Se hospitaliza.

DIAGNÓSTICOS

- I500 Insuficiencia cardíaca congestiva
- I10X Hipertensión esencial

ÓRDENES

- Péptido natriurético, creatinina, electrolitos. Justificación: Confirmar descompensación y vigilar función renal con diurético.
- Radiografía de tórax. Justificación: Evaluar congestión pulmonar y derrame.

RESULTADOS

- Péptido natriurético tipo B: 1.850 pg/mL. Interpretación: Confirma falla cardíaca descompensada.
- Radiografía de tórax: cardiomegalia y redistribución de flujo. Interpretación: Congestión pulmonar.

PLAN DE MANEJO

- Furosemida 40 mg intravenosa cada 8 horas.
- Oxígeno por cánula nasal a 3 litros por minuto.
- Restricción hídrica a 1.200 mL por día y control de peso diario.
- Enalapril 10 mg vía oral cada 12 horas.

EVOLUCIÓN

13-05-2026 12:12 · Día 2: Mejoría de la disnea, diuresis 2.400 mL en 24 horas, peso 2 kg menos. Se continúa

diurético intravenoso.

14-05-2026 17:40 · Día 3: Sin ortopnea, SatO2 94 % al aire ambiente, edema grado I. Se pasa furosemida a vía oral.

EPICRISIS

15-05-2026 08:54 · Día 4: Egreso con mejoría clínica. Diagnósticos de egreso: insuficiencia cardíaca congestiva descompensada e hipertensión arterial. Plan: furosemida 40 mg vía oral cada 12 horas, enalapril 10 mg cada 12 horas, control por cardiología en 15 días, signos de alarma explicados.

PROFESIONAL

Atendido por: Tomas Wilson Ramos Salazar. Registro médico: RM-15451. Especialidad: Medicina interna. Firma electrónica registrada.

Fecha y hora de la anotación: 12-05-2026 15:46